

Consentimiento informado y confidencialidad

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

El **consentimiento informado** y la **confidencialidad médica** son pilares fundamentales de la ética clínica y de la relación médico–paciente. Representan la materialización práctica de los principios de **autonomía, beneficencia y respeto por la dignidad humana**.

En Chile, ambos derechos están garantizados por la **Ley 20.584 (2012)**, que regula los derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. Esta ley aplica en todos los niveles del sistema —público y privado— y es una materia recurrente en el **EUNACOM**, ya que el médico general debe dominar sus aspectos conceptuales, legales y prácticos.

Su relevancia trasciende la práctica clínica individual, siendo también una herramienta de **salud pública**: fomenta la confianza en los servicios de salud, mejora la adherencia terapéutica y protege a la población frente a vulneraciones éticas o abusos de poder sanitario.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Consentimiento informado

Definición (OMS, 2022):

Es el proceso mediante el cual una persona, debidamente informada y en plena capacidad, **acepta o rechaza voluntariamente** un procedimiento diagnóstico o terapéutico, luego de haber recibido información comprensible sobre su naturaleza, riesgos, beneficios y alternativas.

No es un simple **documento firmado**, sino un **proceso comunicativo** continuo entre médico y paciente basado en confianza y respeto.

Objetivo: Garantizar la **autonomía** del paciente y su participación activa en decisiones sobre su salud.

2.2. Confidencialidad

Definición:

Es el deber ético y legal del profesional de salud de **resguardar la información personal y clínica** obtenida en el ejercicio de su profesión, evitando su divulgación no autorizada.

Basada en el principio de **no maleficencia** y en el derecho a la **intimidad y vida privada**, la confidencialidad constituye uno de los fundamentos históricos del juramento hipocrático y mantiene vigencia plena en la práctica médica moderna.

2.3. Fundamento ético–jurídico

Principio ético	Aplicación práctica
Autonomía	Capacidad de decidir libremente sobre procedimientos y tratamientos.
Beneficencia	El médico actúa en beneficio del paciente, informando adecuadamente.
No maleficencia	Evita daños derivados de la falta de información o la divulgación indebida.
Justicia	Asegura trato equitativo y respeto de derechos para todos los pacientes.

3. Marco normativo chileno

3.1. Ley 20.584 (2012) — Derechos y deberes de los pacientes

Artículo 14–17: Regula el consentimiento informado.

Artículo 23–25: Protege la confidencialidad de la ficha clínica y la información sanitaria.

Elementos esenciales del consentimiento informado según la ley:

1. **Explicación clara y completa** sobre diagnóstico, tratamiento y alternativas.
2. **Indicación de riesgos y beneficios esperados.**
3. **Derecho a rechazar o suspender procedimientos.**

- 4. **Consentimiento escrito** cuando se trate de intervenciones invasivas, riesgos vitales o investigaciones biomédicas.
- 5. **Registro obligatorio en ficha clínica.**

3.2. Ley 19.628 — Protección de datos personales

Establece que los **datos de salud** son “sensibles” y solo pueden ser tratados con autorización expresa del titular o según lo dispuesto por ley.

Ejemplo: No se puede entregar resultados de exámenes o antecedentes clínicos a terceros (incluidos familiares) sin autorización del paciente, salvo excepciones legales.

3.3. Ley 20.120 (Investigación científica en seres humanos)

Reafirma que **ninguna persona puede ser sometida a experimentación médica sin consentimiento previo, libre e informado.**

4. Elementos del consentimiento informado

El consentimiento debe cumplir tres condiciones esenciales:

Elemento	Descripción	Ejemplo práctico
Información	Explicación clara, veraz y completa sobre diagnóstico, procedimientos, riesgos, beneficios y alternativas.	Antes de una cirugía, el médico detalla riesgos anestésicos y resultados esperados.
Voluntariedad	Decisión libre, sin coerción ni manipulación.	El paciente puede rechazar un tratamiento sin perder otros derechos.

Competencia (capacidad)	El paciente debe comprender la información y decidir racionalmente.	En pacientes con demencia, decide el representante legal.
--------------------------------	---	---

4.1. Tipos de consentimiento

Tipo	Características	Ejemplo
Verbal	Aceptación oral, habitual en procedimientos rutinarios.	Toma de presión arterial.
Escrito	Requerido en procedimientos invasivos o con riesgo vital.	Cirugía, anestesia, transfusión.
Tácito	Se asume por la conducta del paciente.	Presentarse a control médico.

4.2. Excepciones legales

No se requiere consentimiento informado cuando:

1. **Existe riesgo vital** y el paciente no puede decidir.
2. **Emergencias sanitarias** o epidemias (ej. vacunación obligatoria).
3. **Mandato judicial o legal.**
4. **Riesgo para terceros** (ej. enfermedades de notificación obligatoria).

En estos casos, el médico debe **actuar en beneficio del paciente y dejar constancia escrita.**

5. Confidencialidad médica

5.1. Alcance

Incluye toda información sobre **diagnóstico, evolución, antecedentes familiares, sexuales o genéticos**, obtenidos durante la relación clínica.

5.2. Sujetos obligados

Todo el personal sanitario (médicos, enfermeras, técnicos, administrativos) está obligado a mantener el **secreto profesional**.

5.3. Excepciones al deber de confidencialidad (Ley 20.584, art. 25)

Se puede revelar información cuando:

1. El paciente **autoriza expresamente**.
2. **Es orden judicial o legal**.
3. **Existe riesgo para la salud pública** (enfermedades de notificación obligatoria).
4. Para la **continuidad asistencial**, dentro del mismo equipo de salud.
5. Cuando se requiera para **investigación anónima aprobada por comité ético**.

5.4. Ficha clínica y acceso a la información

- Es **propiedad del paciente**; el establecimiento solo la custodia.
- El paciente o su representante tiene derecho a **acceso, copia y rectificación**.
- Solo puede ser entregada a terceros con consentimiento o por orden judicial.
- En caso de fallecimiento, los familiares directos pueden solicitar acceso parcial (salvo voluntad contraria del paciente).

6. Situaciones clínicas frecuentes y su manejo ético

Situación

Conducta ética correcta

Paciente con enfermedad grave que no desea informar a su familia	Respetar su decisión y registrar en ficha clínica.
Adolescente que consulta por anticoncepción sin informar a padres	Brindar atención confidencial según Ley 20.418 (Derechos sexuales y reproductivos).
Comunicación de resultados de VIH	Solo al paciente; derivar con consentimiento informado.
Solicitud judicial de ficha clínica	Entregar copia certificada según lo solicitado.
Urgencia vital en paciente inconsciente	Actuar sin consentimiento previo y dejar constancia escrita.

7. Rol del médico general y competencias en APS

Rol	Descripción	Ejemplo práctico
Educador en derechos sanitarios	Informa a pacientes sobre su autonomía y confidencialidad.	Explica consentimiento antes de un PAP.
Garantizador ético	Asegura decisiones libres y bien informadas.	Rechazo de transfusión por motivos religiosos.
Custodio de información	Protege fichas y datos sensibles.	Uso de claves personales en registros clínicos electrónicos.

Comunicador empático	Fomenta confianza en la relación médico-paciente.	Explica efectos secundarios de tratamientos en lenguaje claro.
Referente en APS	Promueve prácticas de consentimiento y confidencialidad en el equipo.	Capacitación en derechos del paciente.

8. Errores comunes en EUNACOM

Error frecuente	Corrección conceptual
Pensar que basta con la firma del paciente	El consentimiento es un proceso , no solo un documento.
Confundir confidencialidad con secreto profesional	La confidencialidad incluye también el manejo institucional de la información.
Omitir registro en ficha clínica	Todo consentimiento debe quedar documentado .
Entregar información a familiares sin autorización	Solo se hace si el paciente lo autoriza o hay riesgo vital.
Divulgar información en redes o medios académicos sin anonimizar	Es falta ética y legal grave.

9. Complicaciones y desafíos actuales

- **Historia clínica electrónica:** riesgo de vulneración de datos personales.

- **Telemedicina:** requiere consentimiento previo para transmisión de datos.
- **Big data y salud digital:** nuevos dilemas sobre anonimización y seguridad.
- **Barreras culturales y lingüísticas:** dificultan el consentimiento real en población migrante o indígena.
- **Equilibrio entre confidencialidad y salud pública:** (ej. brotes epidémicos, VIH, salud mental).

El desafío contemporáneo es **conciliar la ética individual con el bien colectivo**, fortaleciendo la educación ética en los equipos de salud.

10. Referencias ministeriales y técnicas

- **Ley 20.584 (2012).** Derechos y deberes de los pacientes.
 - **Ley 19.628 (1999).** Protección de datos personales.
 - **Ley 20.120 (2006).** Investigación científica en seres humanos.
 - **Ley 20.418 (2010).** Derechos sexuales y reproductivos.
 - **MINSAL (2021).** Guía de Ética en Atención de Salud.
 - **OPS/OMS (2022).** Ética en la Atención Sanitaria.
 - **UNESCO (2005).** Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos.
-

11. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. El **consentimiento informado** es un proceso continuo que garantiza la autonomía y la participación activa del paciente.
2. La **confidencialidad médica** protege la intimidad y los datos personales, siendo una obligación ética y legal.
3. La **Ley 20.584** es la base normativa chilena sobre derechos del paciente, incluyendo consentimiento, acceso y confidencialidad.

4. El consentimiento debe ser **informado, voluntario, competente y documentado**.
5. Las excepciones a la confidencialidad y al consentimiento se limitan a situaciones de **riesgo vital, salud pública o mandato judicial**.
6. El médico general es **garante de los derechos humanos y sanitarios**, no solo ejecutor de procedimientos clínicos.
7. En APS, estos principios fortalecen la **confianza, adherencia y calidad** del vínculo terapéutico, núcleo del modelo de salud familiar y comunitaria.